



Série de révision / Concours de Résidanat

S7 : ASTHME DE L'ENFANT

Nesrine Jammeli

Service de Pédiatrie

EPS Taher Sfar, Mahdia

1. Les mécanismes étiopathogéniques de l'asthme allergique de l'enfant font intervenir :

- A- Une atopie familiale et personnelle
- B- Une hyperréactivité bronchique à des stimuli spécifiques
- C- Une prédisposition masculine à la petite enfance
- D- Une corrélation de l'obésité à l'asthme mal contrôlé
- E- Un rôle protecteur de l'utilisation des antibiotiques

2. La broncho-motricité est déterminée physiologiquement par :

- A- Un centre respiratoire bulbaire
- B- Des voies efférentes sensibles
- C- Des mécanorécepteurs à adaptation rapide
- D- Un système cholinergique broncho-constricteur
- E- Une innervation adrénergique broncho-dilatatrice

3. Les facteurs broncho-constricteurs relargués par les mastocytes bronchiques sont :

- A- Le monoxyde d'azote
- B- La prostaglandine E2
- C- La tryptase
- D- L'histamine
- E- La leucotriène D4

4. Le déficit ventilatoire obstructif chez l'enfant asthmatique, au début de la maladie, résulte des mécanismes physiopathologiques suivants :

- A- L'hyper réactivité bronchique
- B- Le remodelage bronchique
- C- L'œdème de la muqueuse bronchique
- D- L'hyper sécrétion bronchique
- E- L'inhalation d'allergènes

5. Concernant le diagnostic positif d'asthme du nourrisson, les propositions exactes sont :

- A- L'asthme du nourrisson est un diagnostic d'élimination
- B- Le diagnostic est retenu devant une toux chronique grasse
- C- Le diagnostic peut être envisagé devant une toux récurrente l'effort
- D- Le diagnostic est évoqué devant la récurrence des dyspnées sifflantes du nourrisson
- E- Le diagnostic peut être confirmé par les explorations fonctionnelles respiratoires

6. Les arguments anamnestiques en faveur du diagnostic de l'asthme de l'enfant sont :

- A- L'exacerbation diurne des symptômes respiratoires
- B- La récurrence des dyspnées sifflantes
- C- L'existence d'une atonie familiale ou personnelle
- D- Le déclenchement de la toux par les émotions
- E- La réversibilité des symptômes sous antibiothérapie

7. Les signes cliniques d'inquiétude contre le diagnostic d'asthme du nourrisson sont :

- A- Les dyspnées sifflantes
- B- La toux chronique
- C- Le wheezing
- D- Le Stridor
- E- L'hypotrophie

8. Le diagnostic de l'asthme de l'enfant d'âge scolaire est basé sur des arguments :

- A- Cliniques
- B- Spirométriques
- C- Allergologiques
- D- Biologiques
- E- Radiologiques

9. Les signes spirométriques en faveur d'un asthme de l'enfant sont :

- A- Un VEMS/CVF inférieur à 0,9
- B- Une variation du VEMS > 12% sur différentes spirométries
- C- Une Chute du VEMS > 15% à l'effort
- D- Une chute du VEMS > 20% au test à la Métacholine
- E- Une augmentation du VEMS > 12% après 200 mcg de salbutamol

10. Les arguments cliniques en faveur d'un asthme allergique chez l'enfant sont :

- A- Une allergie aux protéines de lait de vache
- B- Une obésité
- C- Un signe de Dennie-morgan
- D- Un reflux gastro-œsophagien
- E- Une dermatite atopique

11. Le traitement de fond de l'asthme du nourrisson repose sur les médicaments suivantes :

- A- Les broncho-dilatateurs de courte durée d'action
- B- La corticothérapie inhalée
- C- La chambre d'inhalation
- D- Les anti-leucotriènes
- E- Les bronchodilatateurs de longue durée d'action

12. Le palier 3 du traitement de l'asthme du grand enfant selon le GINA 2021 est basé sur :

- A- Une corticothérapie inhalée de dose moyenne et béta2 de longue durée d'action
- B- Une corticothérapie de dose faible et formotérol
- C- Une association de corticothérapie inhalée et anti-leucotriène
- D- Une association de béta2 de courte durée d'action et corticothérapie orale
- E- Une association de corticothérapie inhalée et d'anti IgE

13. Lesquelles parmi les propositions suivantes constituent des effets indésirables de l'inhalation de béta2 de courte durée d'action :

- A- Une tachycardie
- B- Un tremblement
- C- Des caries dentaires
- D- Une hypotension artérielle
- E- Une hyperglycémie

14. Concernant le sulfate de magnésium prescrit dans l'asthme, les propositions suivantes sont exactes :

- A- Il est indiqué dans la crise d'asthme sévère
- B- Il est indiqué de 1^{ère} intention comme traitement d'urgence
- C- Il expose au risque de tachycardie
- D- Il est administré par voie intra veineuse
- E- Il ne doit pas être associé à l'Atrovent

Cas clinique (1) :

Raed, âgé de 15 mois, originaire de Mahdia, consulte pour encombrement récidivant et la survenue de 4 épisodes de dyspnées sifflantes traitées en ambulatoire par nébulisations de Béta2mimétiques avec des intervalles asymptomatiques entre les épisodes.

Les parents sont consanguins de 2^{ème} degré et suivis pour rhinite allergique.

Le père, par ailleurs, est tabagique.

Il a une sœur de 4 ans ayant eu une allergie aux protéines de lait de vache (APLV) résolue à l'âge de 1 an. Raed avait un antécédent de reflux gastro-œsophagien (RGO) disparu vers l'âge de 8 mois.

A l'examen physique, il avait une dermatite atopique, par ailleurs, normal. Vous reprenez le diagnostic d'asthme du nourrisson.

1. Les arguments cliniques en faveur du diagnostic de l'asthme du nourrisson chez Raed sont :

- A- Le tabagisme passif chez le nourrisson
- B- L'antécédent de RGO chez le nourrisson
- C- L'antécédent d'APLV chez la sœur
- D- La récurrence des dyspnées sifflantes
- E- La dermatite atopique chez le nourrisson

2. L'examen complémentaire de 1^{ère} intention que vous demanderez pour Raed est :

- A- Une numération formule sanguine (NFS)
- B- Des IgE spécifiques alimentaires
- C- Une radiographie de thorax
- D- Une spirométrie
- E- Des prick tests respiratoires

3. Le traitement de fond d'asthme de Raed consiste en la prescription de :

- A- Une chambre d'inhalation
- B- Une Béta2 de courte durée d'action inhalée
- C- Une corticothérapie inhalée
- D- Un anti leucotriène
- E- Un anti cholinergique inhalé

Après un mois de traitement de fond, Raed a été ramené aux urgences pour exacerbation de son asthme survenue après exposition aux fumées de tabac de son père. A l'examen, il était apyrétique, il avait une fréquence respiratoire à 50 c/min, une fréquence cardiaque à 120 bpm, un tirage sous et inter costal intense avec difficulté de têter et des râles sibilants à l'auscultation pulmonaire. La saturation de l'oxygène à l'air ambiant était à 91%.

4. Les signes de gravité de l'exacerbation d'asthme présentée par Raed sont:

- A- Les signes de lutte respiratoires
- B- La saturation à 89%
- C- L'absence de fièvre
- D- Le wheezing
- E- La fréquence respiratoire à 50c/min

5. Le traitement de la crise d'asthme que vous prescriviez pour Raed consiste en :

- A- Une bêta2 de courte durée d'action
- B- Une corticothérapie systémique à H2 de la crise
- C- Le sulfate de magnésium à H1 de la crise
- D- Une antibiothérapie intra veineuse
- E- Un anti cholinergique inhalée

6. Parmi ces mesures adjuvantes du traitement de l'asthme, celles qui doivent être recommandées pour Raed sont :

- A- Délivrer un plan d'action écrit aux parents
- B- Proscrire le tabagisme chez le père à domicile
- C- Une immunothérapie allergénique
- D- Une ablation des végétations adénoïdes
- E- Une vaccination anti grippale

Cas clinique (2) :

Youssef, âgé de 7 ans est suivi pour asthme et une rhinite persistante depuis 1 an. Sa mère est, également, asthmatique. Il vit dans une maison contenant de l'humidité possédant des peluches dans sa chambre à coucher individuelle. Par ailleurs, il a un chat domestique gardé dans le cours de la maison et son père est tabagique. A l'examen, Youssef a un poids à + 2,5 déviations standards, une obstruction nasale surtout nocturne, le reste de l'examen, est par ailleurs, sans anomalies.

Il est traité par fluticasone à faible dose de façon quotidienne par chambre d'inhalation en plus d'un salbutamol inhalé en cas de gêne.

1. Les comorbidités de l'asthme présentées par Youssef sont :

- A- Le tabagisme passif
- B- La rhinite persistante
- C- L'humidité domestique
- D- L'obésité de l'enfant
- E- L'animal domestique

2. En se basant sur l'escalade thérapeutique du GINA (2021), la charge du traitement de fond de Youssef située au :

A- Palier 1

B- Palier 2

C- Palier 3

D- Palier 4

E- Palier 5

3. L'enquête allergologique de 1^{ère} intention que vous demanderez à Youssef comprend :

A- Des prick tests respiratoires

B- Un dosage des IgE totales

C- Une numération formule sanguine

D- Des IgE spécifiques respiratoires

E- Un dosage des antigènes recombinants

Youssef est observant de son traitement de fond, cependant, il se plaint de 2 réveils nocturnes pour sifflement et d'une gêne diurne par semaine avec une dyspnée d'effort au moment des jeux. L'exploration allergologique a identifié une allergie aux acariens.

4. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) qui caractérise(nt) l'asthme de Youssef :

- A- Il a un asthme modéré
- B- Il a un asthme partiellement contrôlé
- C- Il a risque d'obstruction fixée
- D- Il a un risque d'évolution défavorable
- E- Il a un risque de décès lié à l'asthme

5. Les mesures de prise en charge que vous préconisez chez Youssef pour améliorer son asthme :

- A- Un traitement de la rhinite allergique
- B- Une perte de poids
- C- Un palier 3 de l'escalade thérapeutique GINA (2021)
- D- Une immunothérapie allergénique anti acariens
- E- Une éviction du tabac et des peluches

6. Une fois, l'asthme de Youssef est contrôlé, vous lui recommandez :

- A- Réduire le traitement au palier 2 du GINA 2021
- B- Refaire les tests allergologiques
- C- Prescrire une vaccination anti grippale
- D- Fournir un plan d'action écrit
- E- Indiquer une immunothérapie allergénique aux acariens